

Información Paciente

Nombre : Octavio Pastor Valenzuela Gonzalez
Edad : 62a 1m 5d
Dirección : Pablo Neruda 3201

Rut : 8.526.086-3
Fecha Nacto: 08/08/1962
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0818452
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 6346 8782

N° Epicrisis
412759

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 01/07/2024 09:22

Días Estadía: 74

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 13/09/2024 00:09

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

INGRESA EN FORMA ELECTIVA A TRANSPLANTE RENAL Y HEPATICO

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Paciente se opera el 01/07 realizandose transplante de riñon e higado , evoluciona :

1) Hemodinamia: Con req. moderados de NAD en su postoperatorio hasta el 06/07, que reinicia el 20/07 en contexto de hematoma perirrenal y anemia, destetado precozmente.Reingresa a UCI el 5/09 con nuevo shock septico en malas condiciones

2) Ventilatorio: Extubado 03/07 post trasplante, con req. intermitentes y bajos de O2 durante hospitalización que ha impresionado por hipervolemia asociada a falla renal. Requirió VMI 26/08 por EPA + sospecha de intoxicación por opioides.Se reintuba el 4/09 en medicina por nuevo cuadro septico , con pulmon blando y buen intercambio inicialmente

3) Infeccioso:

- Inicialmente cubierto con ampicilina sulbactam profiláctico post trasplante. Destaca 03/07 en cultivo de líquido de preservación, transporte y UC (+) para C. krusei, por lo que se trató por 28 días con Anidulafungina.

- 06/07 bacteriemia por KPN NDM, se manejó con Ceftazidima/avibactam + Aztreonam y se estudió con TC TAP que evidencia colecciones perihepáticas de 13x4 cm en LHD y 8x8x5.5 cm en LII. Manejado con aseo quirúrgico 08/07 del que destaca cultivo (+) KPN NDM + VRE y nuevos HC del 12/07 (+) E. faecium van B, por lo que se agregó Linezolid. Al seguimiento de HC desde el 18/07 (-), desde el 24/07 se cambia esquema a Tigeciclina que mantiene hasta ahora.

- Cultivo de hematoma perirrenal drenado qx 22/07 (+) E. gallinarum y E. faecium van B, se mantuvo Tigeciclina. A la última evaluación por infectología y por tendencia a la disminución de colecciones y hematoma en imágenes, queda plan de mantener esquema de Tigeciclina y controlar TC en 2 semanas.

- Curso con herpes oral tratado con aciclovir, desde entonces mantiene profilaxis, además de cotrimoxazol profiláctico.

Nuevo hit infeccioso que lo lleva al shock septico , se pancultiva el 04/09 con levaduras en hemocultivo y cultivo de rama de tunelizado con candida por lo que inicia tratamiento con voriconazol

4) Renal: Cursa con disfunción precoz del injerto obs 2° a NTA, requiriendo HD desde su ingreso por FAV. Del estudio, Doppler con signos de nefropatía médica, permeabilidad vascular adecuada y hematoma perirrenal, este último drenado en pabellón el 22/07. Se realizó biopsia del injerto 22/08, resultado preliminar sugerente de NTA, sin elementos de MAT ni rechazo. En cuanto a inmunosupresión, se indujo con MPDN y Basiliximab, posteriormente esquema de Prednisona + Tacrolimus + Micofenolato, este último cambiado por Azatioprina dada sospecha de RAM con pancitopenia asociada a micofenolato.

En relacion al ultimo hit infeccioso se indica diálisis de alto volumen con lo que no disminuye drogas si no que se mantiene en iguales condiciones , se suspende el 12/09 a las 13 hrs

5) Urológico: En el estudio de disfunción del injerto destaca Eco doppler con hematoma perirrenal, drenado en pabellón el 22/07. Mantuvo drenaje Jackson Pratt hasta el 03/09. Ha cursado con hematuria intermitente desde auto-retiro de CUP 26/08 asociado con coagulopatía de difícil manejo y trombocitopenia persistente.

Fecha Epicrisis : 13/09/2024 00:41

Fecha Última Actualización: 13-09-2024 0:41:56

Página 2 de 2

6) Hepático: Ingres a para trasplante hepático (y renal), con evolución favorable en lo hepático, pruebas hepáticas ya normalizadas excepto por coagulopatía, en seguimiento por trasplante.

7) Digestivo: Por evento de HDA tiene EDA 02/08 incompleta, nueva EDA 04/08 con múltiples úlceras antrales Forrest III en manejo con IBP desde entonces.

8) Hematológico: Evoluciona con pancitopenia, principalmente neutropenia profunda y trombocitopenia severa, además de coagulopatía persistente que no respondió a vitamina K y tampoco presenta respuesta clara a crioprecipitado, sospechando componentes de toxicidad farmacológica (micofenolato, ya suspendido), virus mielotropos y sepsis (se planteó CID crónica, parece menos probable). En el estudio realizado tiene múltiples PCR CMV (-), IgM VEB (-), convenios Herpes 6 y Parvovirus B19 tomados hoy, EFP en sangre sin peak monoclonal, hipogammaglobulinemia leve, ferritina 547, TG normales, perfil ferroprivo (se desestimó cargar, también se desestimó inicio de EPO), niveles de FVIII normales post-crioprecipitado.

En su último ingreso a UCI con plaquetopenia severa que requiere múltiples transfusiones, y neutropenia severa de 200 blancos

9) Quirúrgico: Además de lo descrito sobre colecciones y hematoma, evoluciona con dehiscencia de la herida operatoria en curaciones y con seguimiento imagenológico.

10) Vascular: Se describe edema de brazo derecho con episodios de eritema y coloración violácea hace al menos 1 mes. Evaluado por vascular indican cuadro 2° a robo por FAV, con indicación de cierre en diferido.

11) Neurológico: Evoluciona con midriasis por lo que se repite TAC de cerebro el día 12/09 el cual muestra sangramiento importante con hemoventrículo y gran edema cerebral

Se le expliva a la familia que no hay pronóstico por lo que se limita el esfuerzo terapéutico falleciendo el 13/09 a las 0: 20 hrs

Diagnóstico de Egreso

CHOQUE SÉPTICO - candidemias sistémica

TRANSPLANTE DE HÍGADO -

TRANSPLANTE DE RIÑÓN -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

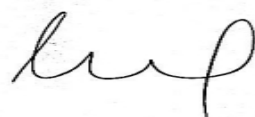
Régimen Alimentario : Hiposódico

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Mariana Valenzuela Giesen
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 13/09/2024 00:41

Página 2 de 2

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:30

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar